

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22232865105 / 926

LAYANNE FERNANDES SAKAI

IDADE: 25 PESO: 64 ALTURA: 1,61 PROFISSÃO: Eng. Produção

SINTOMAS: sonolência diurna, cansaço

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: não toma

MÉDICO: Dra. Lúndia (Otorrino)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 6x academia 1x futebol

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 21:30-22:30

HORA QUE DORME: 23h-23:30h HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILO: () S (X) N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 15,9 e/h SPO2: 80%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: IDR: 24,6/h

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Sinoplectia + Corção deixo septo

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: 94% PRESSÃO NO EXAME: 6 cm H₂O

IAH: 0,80 e/h 80% mínima média

04/10/24 Avaliação

14/10 P= 6 cm H₂O - Relata ter apresentado
24 IAH= 0,8 e/h - dor de cabeça prox. ao
m. de uso: 6h10' alívio.
- melhorou sonolência

21/10 P= 6 cm H₂O - Relata melhora da dor
24 IAH= 0,8 e/h - de cabeça e sonolência
m. de uso: 6h30' -
Dorme a noite toda -
Comprei S10 B. -
fuer

11/11 P= 6 cm H₂O Bem adaptada.

24 IAH= 0,8 e/h
fupcu= 14.9 lpm
m. de uso: 6h40'

fuer

P = 6cmH₂O

IAH = 0,7 elv

M. de uso: 6h 16'

fuga = 4.1

note

Relata que ficou 3d, sem
uso e acordou várias.

lua.

07/04

P = 6cmH₂O

0025

IAH = 0,7 elv

M. de uso = 4h30min

fuga = 2,02/min

nao saiu today / estava mudando casa

* novo filtro *

Silvia

09/06

P = 6cmH₂O

25

IAH = 0,5 elv

M. de uso: 4h40'

- melhora dos sintomas.
- Dor no lado > parte da noite.



ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Layanne Fernandes Sakai
EXAME nº: 5622-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 19/08/2024
IDADE: 25 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 22h11min e concluído às 05h57min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 58 minutos. O tempo total de sono foi de 455,5 minutos (07h35min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 97,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 1,9% de estágio 1, 51% de estágio 2, 19,6% de estágio 3 e 27,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 5 minutos em vigília, ocorreram 81 microdespertares (índice: 10,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 0,8/hora, sendo 0 apneia/hora e 0,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 0,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 94% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa small (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6 cm de H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (0,8/hora; índice normal: 4/hora) e de distúrbio respiratório (0,8/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se poucos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 55; máxima: 77 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min) – ela ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h10min. A latência para o estágio REM estava encurtada (58 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (97,6%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (10,7/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio REM (27,4%; normal: 20-25%). As porcentagens dos estágios 1 (1,9%; normal: 5%), 2 (51%; normal: 45-55%) e 3 (19,6%; normal: 15-20%) mantiveram-se nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Layanne Fernandes Sakai
EXAME nº: 5622
SOLICITADO POR: Dra. Carolina Ruston Daher
DATA: 21/05/2024
IDADE: 25 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h37min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 109 minutos. O tempo total de sono foi de 422,5 minutos (07h02min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 96,8%. A distribuição do sono registrado mostrou 12,7% de estágio 1, 36,2% de estágio 2, 33,4% de estágio 3 e 17,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 7 minutos em vigília, ocorreram 190 microdespertares (índice: 27/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 15,9/hora, sendo 0 apneia/hora e 15,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 24,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 94% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (15,9/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (24,6/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 60; máxima: 83 bpm.

Ela não roncou.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (109 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência adequada (96,8%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 27/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,7%; normal: 5%) e 3 (33,4%; normal: 15-20%), e a redução dos estágios 2 (36,2%; normal: 45-55%) e REM (17,8%; normal: 20-25%).

O índice de movimentos periódicos de membros (2,4/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 13 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).